

TEMA 3.45 • OBSTETRICIA

Metrorragias del Parto (Intraparto)

PERFIL EUNACOM 1.03.45

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Metrorragias del Parto (Intraparto)

1. Rotura Uterina

Causa: Cesárea previa (2 segmentarias, 1 corporal, 1 + misoprostol).

- **Clínica:**
- Contracciones dolorosas que **cesan de repente** (feto va hacia cavidad abdominal)
- Dolor constante residual
- **Pérdida de presentación** en tacto vaginal (presentación sube)
- Feto "más angular" (sin útero que lo cubra)
- Sufrimiento fetal agudo + metrorragia

Manejo: Cesárea urgente → reparación uterina (si posible) o **histerectomía** (según paridad y daño).

2. Rotura de Vasa Previa

Causa: Inserción velamentosa del cordón + vasos pasan por el OCI.

- **Clínica:**
- Metrorragia al momento de la **rotura de membranas** (RAM o RPE)
- **Sufrimiento fetal agudo** (sangre es del feto → se desangra)
- Puede ser una metrorragia escasa pero de origen fetal

Manejo: Cesárea urgente (contraíndica parto vaginal + sufrimiento fetal grave).

NOTA CLÍNICA

Vasa previa asintomática diagnosticada prenatalmente: puede resolverse espontáneamente si vasos se elevan al crecer el útero. Si persiste → **cesárea electiva al término** (parto vaginal absolutamente contraindicado).

3. DPPNI Intraparto

Causa: Desprendimiento ex vacuo (al vaciarse el saco amniótico al romperse membranas).

- **Clínica:**
- Similar a vasa previa (metrorragia tras rotura de membranas + sufrimiento fetal)
- **Diferencia:** + **hipertonía uterina** + contracciones dolorosas

Manejo: Vía más expedita (fórceps si condiciones; cesárea urgente si no).

4. Acretismo Placentario Intraparto

Causa: Placenta previa + cesárea previa.

Clínica: Metrorragia durante el **alumbramiento** (post-nacimiento). Placenta no se desprende.

Manejo: **Histerectomía** (la placenta está adherida; tracción fuerte → inversión uterina).

5. Procidencia / Prolapso de Cordón

No es metrorragia, pero emergencia obstétrica asociada a rotura de membranas.

- **Clínica:**
- Cordón cae antes que la presentación → comprimido por la cabeza
- Sufrimiento fetal agudo **sin metrorragia** (post-rotura membranas)
- **Manejo:**
- Elevar manualmente la presentación (aliviar compresión del cordón)
- **Cesárea urgente**

Tabla Comparativa

TABLA 3.45.1: PATOLOGÍA VS MOMENTO				
PATOLOGÍA	MOMENTO	METRRORRAGIA	SF AGUDO	HALLAZGO CLAVE
Rotura uterina	Cualquier fase	±	Sí	Contracciones cesan + pierde presentación
Rotura vasa previa	Al romper membranas	Sí (sangre fetal)	Sí (grave)	Escasa pero fetal
DPPNI intraparto	Al romper membranas	Sí	Sí	+ hipertonía uterina
Acretismo	Alumbramiento	Sí (postparto)	No	Placenta no se desprende
Procidencia cordón	Al romper membranas	No	Sí	Cordón palpable en tacto vaginal

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Diferencia clave: Post-rotura de membranas → SF con metrorragia = vasa previa o DPPNI. SF **sin** metrorragia = procidencia de cordón.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Metrorragias del Parto (Intraparto), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Metrorragias del Parto (Intraparto). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- 1. Rotura Uterina
- 2. Rotura de Vasa Previa
- 3. DPPNI Intraparto
- 4. Acretismo Placentario Intraparto
- 5. Procidencia / Prolapso de Cordón
- Tabla Comparativa
- Cesárea previa (2 segmentarias, 1 corporal, 1 + misoprostol).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (METRORRAGIAS DEL PARTO (INTRAPARTO))**PREGUNTA 1**

Respecto a Metrorragias del Parto (Intraparto), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Metrorragias del Parto (Intraparto) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Metrorragias del Parto (Intraparto) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Metrorragias del Parto (Intraparto) requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Metrorragias del Parto (Intraparto) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Metrorragias del Parto (Intraparto) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Metrorragias del Parto (Intraparto)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Metrorragias del Parto (Intraparto). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: METRORRAGIAS DEL PARTO (INTRAPARTO)

:::note Vasa previa asintomática diagnosticada prenatalmente: puede resolverse espontáneamente si vasos se elevan al crecer el útero. Si persiste → cesárea electiva al término (parto vaginal absolutamente contraindicado). :::
:::warning Diferencia clave: Post-rotura de membranas → SF con metrorragia = vasa previa o DPPNI. SF sin metrorragia = procidencia de cordón. :::